

MetaBotism

فراز کے لیے ذہین غذائی، عادت سازی اور زرخیزی معاون کوچ

Product Vision, Clinical Context, Technical Architecture and Codex Handoff

یہ دستاویز ابتدائی گفتگو سے حاصل شدہ طبی پس منظر، درست کی گئی غلط فہمیاں، غذائی منصوبہ، پروڈکٹ وژن، حفاظتی اصول، وی پی ایس فن تعمیر، تعیناتی کے مراحل اور Codex کے لیے واضح تعمیراتی ہدایات یکجا کرتی ہے۔

تیار کی تاریخ: بائیس جولائی دو ہزار چھبیس

ابتدائی ہدفی ٹیسٹ: دو نومبر دو ہزار چھبیس

خفیہ: اس دستاویز میں حساس صحت سے متعلق معلومات شامل ہیں۔

فہرست عنوانات

8	1 دستاویز کا مقصد
8	2 پروڈکٹ کا نام اور بنیادی تصور
8	2.1 نام
8	2.2 ایک جملے میں وژن
8	2.3 مسئلہ جسے حل کرنا ہے
8	2.4 برانڈ شخصیت
9	3 صارف اور طبی منظر
9	3.1 بنیادی پروفائل
9	3.2 ماحولیاتی اور معمول کے عوامل
9	3.3 اہم طبی حد
10	4 رپورٹوں کا درست ریکارڈ
10	4.1 تاریخوں کی تصحیح
10	4.2 اپریل دو ہزار پچیس: اصل نمونہ
10	4.3 جولائی دو ہزار چھیس: اصل نمونہ
11	4.4 اصل موازنہ
11	4.5 لیبارٹری صفائی کے بعد: اپریل دو ہزار پچیس
11	4.6 لیبارٹری صفائی کے بعد: جولائی دو ہزار چھیس
12	4.7 ساخت یا مورفولوجی
12	4.8 تخمینی تعداد کی وضاحت
13	5 گفتگو میں حل کی گئی اہم غلط فہمیاں
13	6 نانٹرکس اور ایجوکیل کا ریکارڈ

- 6.1 نانٹرکس 13
- 6.2 ایبوکیل 14

14

7 منظور شدہ غذائی اور معمول کا منصوبہ

- 7.1 مدت 14
- 7.2 روزانہ تین غذائی موقع 14
- 7.3 روزانہ کا بنیادی سانچہ 14
- 7.4 ہفتہ وار پروٹین چکر 15
- 7.5 پرہیز 15
- 7.6 حرکت، نیند اور گرمی 15
- 7.7 ٹیسٹ کی تیاری 16

16

8 MetaBotism کا صارف تجربہ

- 8.1 واٹس ایپ جیسی شکل 16
- 8.2 فوری جواب کے بٹن 16
- 8.3 صبح کا نمونہ پیغام 17
- 8.4 کام نہ ہونے پر رد عمل 17
- 8.5 رات کا حساب 17

17

9 موٹیویشن اور روایتی منطق

- 9.1 سختی کی حد 17
- 9.2 موٹیویشن کا اصول 17
- 9.3 انعام 18

18

10 گروسری اور پانڈا مارٹ

- 10.1 ہفتہ وار فہرست 18
- 10.2 پانڈا مارٹ کی عملی حد 18

18

11 فن تعمیر کی تجویز

18	11.1 تجویز کردہ شکل
19	11.2 موبائل ایپ
19	11.3 وی پی ایس بیک اینڈ
19	11.4 اہم سروسز
20	12 اے آئی ڈیزائن
20	12.1 دوپرتوں کا اصول
20	12.2 اے آئی کے مجاز کام
20	12.3 اے آئی کے ممنوع کام
21	12.4 بنیادی نظامی ہدایت کا خلاصہ
21	13 طبی حفاظتی نظام
21	13.1 فوری طبی حوالہ
21	13.2 طبی زبان
22	14 رازداری، رضامندی اور سلامتی
22	15 ڈیٹا ماڈل کا منطقی خاکہ
23	16 اہم صارف بہاؤ
23	16.1 ابتدائی سیٹ اپ
23	16.2 روزانہ بہاؤ
23	16.3 ہفتہ وار بہاؤ
23	16.4 ٹیسٹ سے پہلے آخری ہفتہ
23	17 پہلا قابل استعمال ورژن
24	18 ترقیاتی مراحل
24	18.1 مرحلہ صفر: توثیق
24	18.2 مرحلہ اول: کلک ہونے والا نمونہ
24	18.3 مرحلہ دوم: آف لائن اے پی کے

24	18.4 مرحلہ سوم: وی پی ایس اور اے آئی
24	18.5 مرحلہ چہارم: آزمائش
25	18.6 مرحلہ پنجم: اگلی وسعت
25	19 قبولیت کے معیار
25	20 آزمائشی منظر نامے
26	21 Codex کے لیے تعمیراتی ہدایت
27	22 کھلے فیصلے
27	23 کامیابی کی پیمائش
28	24 حوالہ جاتی اصول
28	25 حتمی پروڈکٹ بیان
26	English Executive Handoff 29
26.1	Product name 29
26.2	Product promise 29
26.3	Primary delivery format 29
26.4	Primary user 29
27	Validated Health Context 29
27.1	User profile 30
27.2	Correct report dates 30
27.3	April two thousand twenty-five raw semen data 30
27.4	July two thousand twenty-six raw semen data 31
27.5	Critical interpretation rule 31
27.6	Post-preparation data 31
27.7	Morphology 32

27.8 Resolved misconceptions	32
28 Supplement Record and Safety	33
28.1 Nitrix	33
28.2 Abocal	33
29 Approved Lifestyle Plan	33
29.1 Initial plan window	33
29.2 Daily meal windows	33
29.3 Daily template	34
29.4 Weekly protein rotation	34
29.5 Avoidance rules	34
29.6 Activity, sleep, and heat	35
29.7 Follow-up test preparation	35
30 Product Vision and Experience	35
30.1 Core experience	35
30.2 Tone	36
30.3 Safe rewards	36
31 Functional Requirements	36
31.1 Onboarding	36
31.2 Today screen	36
31.3 Chat screen	37
31.4 Meal engine	37
31.5 Grocery engine	37
31.6 Adherence and reports	37
31.7 Test countdown	37
32 AI Behaviour Contract	38

32.1 Two-layer architecture	38
32.2 Allowed model behaviour	38
32.3 Prohibited model behaviour	38
32.4 Response structure	38
32.5 Hallucination control	38
33 Technical Architecture	38
33.1 Android client	39
33.2 VPS deployment	39
33.3 Server components	39
33.4 Secret management	40
33.5 WhatsApp integration	40
34 Logical Data Model	40
35 Privacy and Security Requirements	41
36 Medical Escalation Rules	41
37 Delivery Roadmap	41
37.1 Discovery and decisions	41
37.2 Clickable prototype	42
37.3 Offline APK	42
37.4 VPS and AI layer	42
37.5 Pilot	42
37.6 Later phases	42
38 Acceptance Criteria	42
39 Codex Build Instructions	43
39.1 Ready-to-use Codex kickoff prompt	44

40 Open Decisions for Codex to Surface	44
41 Success Metrics	45
42 Final English Product Statement	45

دستاویز کا مقصد

یہ روڈ میپ Codex کو اتنا مکمل پس منظر دینے کے لیے ہے کہ وہ سابقہ گفتگو دوبارہ مانگے بغیر MetaBotism کی منصوبہ بندی، کوڈنگ، آزمائش اور تعیناتی شروع کر سکے۔ یہ خام چیٹ کا لفظ بہ لفظ نقل نہیں، بلکہ گفتگو کا منظم، تصحیح شدہ اور قابل عمل خلاصہ ہے۔

مرکزی نتیجہ: MetaBotism ایک عام چیٹ بوٹ، مردانہ طاقت کی ایپ یا بیماری تشخیص کرنے والا ڈاکٹر نہیں ہوگا۔ یہ ایک سخت مگر ہمدرد، اردو زبان میں کام کرنے والا روزانہ کا غذائی و عادت سازی کوچ ہوگا جو منظور شدہ منصوبے پر عمل کروائے گا، واضح وجہ بتائے گا، متبادل دے گا، خریداری منظم کرے گا اور اگلے منی ٹیسٹ تک تسلسل قائم رکھے گا۔

پروڈکٹ کا نام اور بنیادی تصور

نام

پروڈکٹ کا حتمی نام: MetaBotism

ایک جملے میں وژن

ایک ایسی وائس ایپ جیسی اینڈرائیڈ ایپ جو فراز کو دن کے ہر اہم وقت پر بتائے کہ کیا کھانا ہے، کیوں کھانا ہے، کیا خریدنا ہے، کیا پکانا ہے، کس چیز سے رکنا ہے، اور کام نہ ہونے پر فوراً قابل عمل متبادل دے۔

مسئلہ جسے حل کرنا ہے

صارف کو معلومات پہلے سے معلوم ہو سکتی ہیں، لیکن مسئلہ معلومات کی کمی نہیں بلکہ روزانہ عمل، خریداری، تیاری، مستقل مزاجی، بوریت اور حساب دہی ہے۔ لمبی فہرست ایک بار پڑھ کر بھول جاتی ہے۔ MetaBotism اس فہرست کو ہر دن کے چھوٹے، واضح اور وقت سے بندھے ہوئے احکامات میں تبدیل کرے گا۔

برانڈ شخصیت

- سخت گیر مگر غیر توہین آمیز۔

- ڈاکٹر جیسی احتیاط، استاد جیسی جواب طلبی، ماہر نفسیات جیسی عادت سازی، اور قریبی دوست جیسی ہمدردی۔

- بہانہ قبول نہ کرے، لیکن حقیقی رکاوٹ پر فوری تبادلہ دے۔
- خوف، شرمندگی یا جھوٹے طبی دعووں سے موٹیویٹ نہ کرے۔
- کامیابی کو صرف نتیجے سے نہیں، مسلسل عمل سے بھی ناپے۔

صارف اور طبی پس منظر

بنیادی پروفائل

مرکزی صارف کا نام فراز ہے۔ عمر تقریباً ساڑھے بیالیس سال، قد تقریباً چھ فٹ، وزن تقریباً ستر سے پچھتر کلو گرام ہے۔ کام زیادہ تر بیٹھ کر ہوتا ہے، لیکن واک جاری رہتی ہے۔ شراب، سگریٹ، نسواریا منشیات کا استعمال رپورٹ نہیں ہوا۔ شوگر کی معلوم بیماری نہیں۔ پہلے قدرتی طور پر اولاد ہو چکی ہے، اس لیے موجودہ معاملہ سابقہ زرخیزی کے بعد پیدا یا برقرار رہنے والی کمزوری کے تناظر میں دیکھا جائے گا۔

ماحولیاتی اور معمول کے عوامل

- جولائی سے اکتوبر دو ہزار چھیس تک گرم علاقے میں قیام۔
- اپریل سے مئی دو ہزار چھیس تک دوبارہ تقریباً ڈیڑھ ماہ شدید گرم ماحول۔
- بعض اوقات محیطی درجہ حرارت پینتیس سے سینتالیس ڈگری تک۔
- مئی دو ہزار چھیس کے بعد نسبتاً ٹھنڈا یا ایر کنڈیشنڈ ماحول۔
- تنگ لباس، مسلسل لیپ ٹاپ رانوں پر یا گرم نشست کی واضح تاریخ نہیں؛ ڈھیلا لباس استعمال ہوا۔
- فروری دو ہزار چھیس سے انڈے، پروٹین اور دیسی گھی؛ آٹا اور چینی وزن کے لیے کم۔

اہم طبی حد

ایپ یہ دعویٰ نہیں کرے گی کہ غذا سے لازماً تیز سیدھی حرکت پیدا ہوگی یا رپورٹ پر فیکٹ ہو جائے گی۔ غذا، نیند، جسمانی سرگرمی اور گرمی سے احتیاط مدد کر سکتے ہیں، لیکن ویریکوسیل، انفیکشن، ہارمون، ساختی مسئلہ یا نامعلوم وجہ کو صرف خوراک درست نہیں کرتی۔ دو غیر معمولی رپورٹس کی صورت میں مردانہ زرخیزی کے یورو لوجسٹ سے جسمانی معائنہ اہم ہے۔

رپورٹوں کا درست ریکارڈ

تاریخوں کی تصحیح

گفتگو میں تاریخوں کی وضاحت کے بعد حتمی ریکارڈ یہ ہے:

- تمام دو ہزار پچیس کے نتائج اپریل دو ہزار پچیس کے ہیں۔
- تمام دو ہزار چھبیس کے نتائج جولائی دو ہزار چھبیس کے ہیں۔

اپریل دو ہزار پچیس: اصل نمونہ

- ارتکاز: تیس ملین فی ملی لیٹر۔
- متحرک تعداد: بارہ ملین فی ملی لیٹر۔
- متحرک فیصد: سینتیس اعشاریہ پانچ فیصد۔
- پورے اخراج میں کل تعداد: ایک سو بارہ ملین۔
- حجم: تقریباً ساڑھے تین ملی لیٹر۔
- تیز سیدھی حرکت: صفر فیصد۔
- آہستہ یا غیر سیدھی آگے بڑھنے والی حرکت: تیس فیصد۔
- غیر پیش قدم حرکت: پندرہ فیصد۔
- غیر متحرک: تریسٹھ فیصد۔

جولائی دو ہزار چھبیس: اصل نمونہ

- ارتکاز: تیس ملین فی ملی لیٹر۔
- متحرک تعداد: نو ملین فی ملی لیٹر۔
- متحرک فیصد: انتالیس اعشاریہ تیرہ فیصد۔
- پورے اخراج میں کل تعداد: اسی اعشاریہ پانچ ملین۔
- حجم: ساڑھے تین ملی لیٹر۔

- تیز سیدھی حرکت: صفر فیصد۔
- آہستہ یا غیر سیدھی آگے بڑھنے والی حرکت: تیس فیصد۔
- غیر پیش قدم حرکت: سولہ فیصد۔
- غیر متحرک: اکسٹھ فیصد۔

اصل موازنہ

تیز سیدھی حرکت دونوں اصل نمونوں میں صفر تھی؛ یہ دو ہزار پچیس سے دو ہزار چھیس میں بیس سے صفر نہیں ہوئی۔ مجموعی حرکت فیصد کے اعتبار سے معمولی بہتر ہوئی، لیکن ارتکاز اور پورے اخراج کی کل تعداد کم ہوئی، اس لیے مطلق متحرک جرثوموں کی تعداد دو ہزار پچیس میں زیادہ تھی۔

پروڈکٹ کی اہم یادداشت: اصل نمونے اور لیبارٹری صفائی کے بعد کے نمونے کو کبھی آپس میں نہ ملایا جائے۔ یہی گفتگو کی سب سے اہم تصحیح تھی۔

لیبارٹری صفائی کے بعد: اپریل دو ہزار پچیس

- طریقہ: PureSperm۔
- استعمال شدہ حجم: ایک ملی لیٹر۔
- صفائی کے بعد کل ارتکاز: پانچ ملین فی ملی لیٹر۔
- صفائی کے بعد متحرک ارتکاز: پانچ ملین فی ملی لیٹر۔
- تیز سیدھی حرکت: بیس فیصد۔
- آہستہ یا غیر سیدھی حرکت: اسی فیصد۔
- آخری حجم: آدھا ملی لیٹر۔
- کل صفائی شدہ متحرک جرثومے: تقریباً ڈھائی ملین۔

لیبارٹری صفائی کے بعد: جولائی دو ہزار چھیس

- طریقہ: PureSperm۔

- استعمال شدہ حجم: ایک ملی لیٹر۔
- صفائی کے بعد کل ارتکاز: چار ملین فی ملی لیٹر۔
- صفائی کے بعد متحرک ارتکاز: چار ملین فی ملی لیٹر۔
- تیز سیدھی حرکت: صفر فیصد۔
- آہستہ یا غیر سیدھی حرکت: سو فیصد۔
- آخری حجم: آدھا ملی لیٹر۔
- کل صفائی شدہ متحرک جرٹومے: تقریباً دو ملین۔

ساخت یا مورفولوجی

دونوں رپورٹوں میں نتائج ایک جیسے تھے:

- مکمل نارمل شکل: ایک فیصد۔
- سرکی ساخت میں خرابی: ننانوے فیصد۔
- درمیانی حصے کی خرابی: صفر فیصد۔
- دم کی خرابی: صفر فیصد۔

اس کا مطلب یہ نہیں کہ ننانوے فیصد ممکنہ بچوں میں پیدائشی نقص ہوگا۔ یہ جرٹومے کی ظاہری ساخت کی سخت لیبارٹری درجہ بندی ہے، بچے کے جینیاتی یا ذہنی مستقبل کی براہ راست رپورٹ نہیں۔ کم نارمل ساخت حمل کے امکان یا وقت کو متاثر کر سکتی ہے، لیکن نارمل ڈلیوری، آپریشن، ذہنی معذوری یا جسمانی معذوری کا فیصلہ اس ایک عدد سے نہیں کیا جاسکتا۔

تخمینی تعداد کی وضاحت

جولائی دو ہزار چھبیس کے اسی اعشاریہ پانچ ملین کل جرٹوموں میں ایک فیصد کا سادہ حساب تقریباً آٹھ لاکھ پانچ ہزار نارمل شکل والے جرٹومے بنتا ہے۔ یہ صرف شکل کا حساب ہے۔ شکل اور حرکت کا مشترک، درست لیبارٹری عدد دستیاب نہیں؛ کسی مشترک تعداد کو صرف تخمینہ کہا جائے گا، حقیقت نہیں۔

گفتگو میں حل کی گئی اہم غلط فہمیاں

- آہستہ مگر آگے بڑھنے والا جرثومہ بھی انڈے تک پہنچ کر اسے بار آور کر سکتا ہے۔ تیز حرکت فائدہ دیتی ہے، مگر صرف تیز گروہ ہی واحد ممکن راستہ نہیں۔
- ایک انڈے میں عموماً ایک جرثومہ داخل ہوتا ہے، پھر انڈہ دوسرے جرثوموں کے داخلے کو روکتا ہے۔
- ایک جرثومہ اور ایک انڈہ بننے کے بعد جنین تقسیم ہو جائے تو ہم شکل جڑواں بچے ہو سکتے ہیں۔ الگ الگ جڑواں بچوں کے لیے عموماً دو انڈے اور دو جرثومے درکار ہوتے ہیں۔
- خاندان میں لڑکوں کی زیادہ تعداد فراز کی جرثومی حرکت، تیز رفتاری یا موروثی کمزوری کا ثبوت نہیں۔ بچوں کی جنس کی خاندانی گنتی منی کے معیار کا ٹیسٹ نہیں۔
- فراز کا پہلے باپ بن چکا ہونا اس وقت کی زرخیزی ثابت کرتا ہے، موجودہ رپورٹ کو خود کار طور پر نارمل نہیں بناتا۔
- عام موبائل اور وائی فائی کو موجودہ رپورٹ کا ثابت شدہ سبب نہیں کہنا۔ طاقت ور طبی یا صنعتی شعاعیں الگ معاملہ ہیں۔
- گرمی ممکنہ معاون سبب ہے، لیکن تیز حرکت اپریل دو ہزار پچیس میں بھی صفر تھی؛ اس لیے دو ہزار چھبیس کی گرمی مکمل بنیادی وضاحت نہیں۔

ناٹریکس اور ایبوکیل کاریکارڈ

ناٹریکس

ڈاکٹر نے دو ہزار پچیس میں Nitrix نامی دس کیپسول والا متبادل سپلیمنٹ لکھا۔ تصویر میں درج اجزاء:

- جنسینگ: ایک سو بیس ملی گرام۔
- ایل ٹورین: ایک سو ملی گرام۔
- یوہمبین: چھ ملی گرام۔
- ٹریبولس: تین سو ملی گرام۔
- ہارنی گوٹ ویڈ: تیس ملی گرام۔
- ایل آر جینین: ایک سو ملی گرام۔
- کلوروفائٹم بورویلیا نم یا سفید موصلی: ایک سو ملی گرام۔
- پائن بارک عرق: بیس ملی گرام۔

- زنک: دس ملی گرام۔

ڈاکٹر کا ممکنہ مقصد منی کی حرکت یا عمومی اینٹی آکسیدنٹ مدد تھا، کیونکہ فراز کو جنسی رغبت یا عضو کی سختی کا مسئلہ نہیں تھا۔ تاہم مقصد اور ثابت شدہ اثر الگ ہیں۔ یہ تیز سیدھی حرکت کا مخصوص یا یقینی علاج نہیں۔ یوہمبین بلڈ پریشر، دل کی دھڑکن، بے چینی اور دوسری دواؤں کے ساتھ تعامل پیدا کر سکتا ہے؛ ایپ اسے خود سے دوبارہ شروع کرنے کا مشورہ نہیں دے گی۔

اپریل دو ہزار پچیس میں صفائی کے بعد ملنے والی بیس فیصد تیز حرکت نائٹرکس کا اثر نہیں تھی، کیونکہ وہ اسی پری نسخہ نمونے کی لیبارٹری صفائی کا نتیجہ تھی۔

ایبوکیل

Abocal میں کیلشیم، وٹامن ڈی تھری، وٹامن سی اور وٹامن بی سکس درج تھے۔ یہ عمومی غذائی یا ہڈیوں کی مدد کا سپلیمنٹ ہے، تیز سیدھی حرکت کی خصوصی دوا نہیں۔ اسے صرف ڈاکٹر یا ثابت شدہ کمی کے مطابق استعمال کیا جائے۔

منظور شدہ غذائی اور معمول کا منصوبہ

مدت

ابتدائی منصوبہ ایکس جولائی دو ہزار چھبیس سے دو نومبر دو ہزار چھبیس تک ہے۔ تاریخیں پروفائل میں قابل تدوین ہوں؛ انہیں کوڈ میں مستقل طور پر نہ باندھا جائے۔

روزانہ تین غذائی مواقع

- پہلا کھانا: صبح آٹھ سے نو بجے۔
- دوسرا کھانا: دوپہر ایک سے دو بجے۔
- تیسرا کھانا: شام ساڑھے سات سے ساڑھے آٹھ بجے۔

روزانہ کا بنیادی سانچہ

- صبح: ایک یا دو ابلے انڈے، ایک ثابت آٹے کی روٹی یا جئی، ایک پھل، اور دہی یا دودھ۔
- دوپہر: دال، چنے، لوبیا، مچھلی یا ہتھیلی کے برابر مرغی؛ ایک یا دو روٹیاں؛ بڑی پلیٹ سلاڈ؛ دہی۔
- خشک میوہ: چار پورے اخروٹ کی گریاں، آٹھ سے دس بادام، اور ایک چمچ کدو کے بیج یا پسی السی۔

- رات: ایک یا دو روٹیاں، پکی سبزی، دال یا مناسب پروٹین، اور سلاد۔
- روزانہ دو مختلف پھل، کم از کم ایک پلیٹ سلاد، ایک پیالہ پکی سبزی، اور مناسب پانی۔
- دیسی گھی زیادہ سے زیادہ ایک چائے کا چمچ: اسے زرخیزی کی دوا نہ کہا جائے۔

ہفتہ وار پروٹین چکر

- مچھلی: ہفتے میں دو مرتبہ۔
- مرغی: ہفتے میں دو مرتبہ۔
- دال، چنے یا لوبیا: کم از کم تین مرتبہ۔
- کم چربی والا سرخ گوشت: زیادہ سے زیادہ ایک مرتبہ۔
- انڈے مناسب مقدار میں روزانہ یا اکثر دن۔

پرہیز

- میٹھے شیک، کولڈ ڈرنکس، انرجی ڈرنکس اور روزانہ جوس نہیں۔
- گہری تلی اشیا، بیکری، چپس اور پراسیسڈ گوشت کم سے کم۔
- بھاری شہد، کھجور، کیلا، خشک میوہ اور کچے انڈے کے روزانہ شیک نہیں۔
- نامعلوم مردانہ طاقت کے پاؤڈر، نائٹرکس، ٹیسٹوسٹیرون یا باڈی بلڈنگ اسٹیرائڈ خود سے نہیں۔
- سکریٹ، شیشہ، نسوار اور شراب مکمل منع۔

حرکت، نیند اور گرمی

- ہفتے کے اکثر دن تیس سے پینتالیس منٹ واک۔
- ہفتے میں دو مرتبہ ہلکی طاقت کی ورزش۔
- ہر پینتالیس سے ساٹھ منٹ بیٹھنے کے بعد پانچ منٹ حرکت۔
- سات سے نو گھنٹے نیند۔

- گرم غسل، سونا، گرم نشست، لیپ ٹاپ رانوں پر اور مسلسل غیر ہوا دار گرمی سے بچاؤ۔
- خصلوں پر برف یا براہ راست شدید ٹھنڈ نہیں۔

ٹیسٹ کی تیاری

ابتدائی ہدف دو نومبر دو ہزار چھیس ہے۔ پچھلی رپورٹ سے بہتر موازنہ کے لیے اسی اچھی لیبارٹری، تقریباً اسی وقت اور چار دن کے وقفے کی کوشش کی جائے۔ اٹھائیس اکتوبر کی شام کے بعد نمونہ دینے تک انزال نہ ہو۔ پورا نمونہ جمع ہو؛ کچھ ضائع ہو تو لیبارٹری کو بتایا جائے۔ تیز بخار یا شدید بیماری کی صورت میں ڈاکٹر سے تاریخ دوبارہ طے کی جائے۔

MetaBotism کا صارف تجربہ

وائس ایپ جیسی شکل

- اوپر پروفائل، آج کی تاریخ، اگلے ٹیسٹ تک باقی مدت اور روزانہ اسکور۔
- درمیان میں چیٹ ببل، کوچ کے احکامات، وضاحت اور صارف کے جوابات۔
- نیچے اردو ٹیکسٹ، وائس ان پٹ اور فوری جواب کے بٹن۔
- الگ ٹیب: آج، گروسری، پیش رفت، طبی ریکارڈ، منصوبہ، ترتیبات۔

فوری جواب کے بٹن

- کر لیا۔
- ابھی کر رہا ہوں۔
- گھر میں موجود نہیں۔
- متبادل بتاؤ۔
- آج باہر ہوں۔
- طبی مسئلہ ہے۔
- خریداری کھولو۔

صبح کا نمونہ پیغام

فراز، ساڑھے آٹھ بج گئے۔ آج کا ناشتہ: دو ابلے انڈے، ایک روٹی، ایک امرود اور ایک پیپالہ دہی۔ انڈے معیاری پروٹین دیتے ہیں، دہی عمومی غذائی مدد دیتا ہے، اور امرود وٹامن سی اور اینٹی آکسیڈنٹ اجزاء فراہم کرتا ہے۔ یہ فوری جادو نہیں؛ مسلسل معمول جسم کو بہتر خام مال دیتا ہے۔ کر لیا یا متبادل چاہیے؟

کام نہ ہونے پر رد عمل

تین یاد دہانیاں ہو چکی ہیں۔ اب بحث نہیں۔ اگر انڈے موجود ہیں تو ابھی ابالو؛ نہیں ہیں تو دہی، پھل اور خشک میوہ والا متبادل منتخب کرو۔ خالی پیٹ رہنا منصوبہ نہیں۔

رات کا حساب

آج تین میں سے دو کھانے درست ہوئے۔ واک باقی ہے۔ دن ختم ہونے میں ابھی وقت ہے؛ دس منٹ چل لو اور آج کا اسکور بچالو۔ کل کی شروعات آج کے ڈسپلن سے ہوگی۔

موٹیویشن اور روایتی منطق

سختی کی حد

ایجنٹ واضح، مختصر اور جواب طلب ہوگا، لیکن گالی، شرمندگی، جسمانی تحقیر، بانجھ کہہ کر خوف یا جذباتی بلیک میل استعمال نہیں کرے گا۔ بار بار ناکامی پر حکم چھوٹا ہوگا، متبادل محدود ہوں گے، اور صارف سے ایک فوری انتخاب لیا جائے گا۔

موٹیویشن کا اصول

ہر کھانے کے ساتھ تین سطحی پیغام:

- آج کیا کرنا ہے۔

- اس خوراک سے عمومی طور پر کیا غذائی مدد ملتی ہے۔

- حقیقت کی حد: فائدہ ممکن ہے، کسی خاص رپورٹ کی ضمانت نہیں۔

انعام

ہفتے میں ایک منصوبہ بند پسندیدہ کھانا، چائے، کتاب، تفریح یا آرام بطور انعام ہو سکتا ہے۔ سگریٹ یا نسوار کبھی انعام نہیں ہوگا۔ فراز پہلے تمباکو استعمال نہیں کرتا؛ ایپ کا اسے شروع کروانا طبی اور اخلاقی طور پر ناقابل قبول ہے۔

ناقابل تبدیل حفاظتی اصول: سگریٹ، نسوار، شیشہ، غیر تجویز شدہ ٹیسٹوسٹیرون، اسٹیرائڈ یا نامعلوم مردانہ طاقت کی دوا کو کبھی اجازت، انعام یا تبادل کے طور پر پیش نہ کیا جائے۔

گروسری اور پانڈا مارٹ

ہفتہ وار فہرست

ایپ موجود اسٹاک، آنے والے سات دن کے مینو اور مقدار کے مطابق اردو فہرست بنائے۔ ہر آئٹم کے ساتھ موجود، کم، ختم، تبادل اور خرید لیا کی حالت ہو۔

پانڈا مارٹ کی عملی حد

ابتدائی ورژن صارف کے لیے فہرست نقل کرے، فوڈ پانڈا یا پانڈا مارٹ کھولے اور تلاش کے الفاظ دے۔ عام خریدار کے لیے قابل اعتماد کھلا خود کار چیک آؤٹ نظام فرض نہ کیا جائے۔ فوڈ پانڈا کا دستیاب پارٹنر اے پی آئی دکانداروں اور آرڈر وصول کرنے والے شراکت داروں کے لیے ہے۔

کسی خریداری، قیمت، مقدار، پتے یا ادائیگی کو صارف کی آخری منظوری کے بغیر حتمی نہ کیا جائے۔

فن تعمیر کی تجویز

تجویز کردہ شکل

پہلا ورژن حقیقی واٹس ایپ بوٹ کے بجائے واٹس ایپ جیسی شکل والی اینڈرائیڈ اے پی کے ہو۔ یہ نجی، کم خرچ، قابل کنٹرول اور ایک صارف کے لیے موزوں ہے۔ بعد میں واٹس ایپ بزنس کلاؤڈ اے پی آئی الگ انضمام ہو سکتا ہے۔

موبائل ایپ

تجویز کردہ اسٹیک:

- React, TypeScript and Capacitor سے اینڈرائیڈ اے پی کے۔
- مقامی ڈیٹا کے لیے SQLite یا محفوظ مقامی اسٹوریج۔
- مقامی یاد دہانی کے لیے Capacitor Local Notifications۔
- سرورپش کے لیے ضرورت پڑنے پر Firebase Cloud Messaging۔
- اردو دائیں سے بائیں انٹرفیس اور قابل رسائی بڑا متن۔
- آف لائن بنیادی منصوبہ؛ آن لائن اے پی گفٹگو۔

وی پی ایس بیک اینڈ

- Ubuntu LTS VPS
- Docker Compose پر اے پی آئی، ورکر، ڈیٹابیس اور ریورس پراکسی۔
- Node.js with TypeScript یا Python FastAPI؛ ٹیم ایک منتخب کرے، دونوں نہ ملائے۔
- PostgreSQL بطور مرکزی ڈیٹابیس۔
- شیڈول کام کے لیے Redis plus a queue worker صرف ضرورت پر؛ ابتدائی ورژن میں ڈیٹابیس شیڈولر کافی ہو سکتا ہے۔
- Caddy یا Nginx، لازمی HTTPS، خودکاریک اپ اور صحت کی نگرانی۔
- اے پی فراہم کنندہ کی خفیہ کلید صرف سرور پر؛ اے پی کے میں کبھی نہیں۔

اہم سروسیں

- شناخت اور پن یا محفوظ لاگ ان۔
- صارف پروفائل اور رضامندی۔
- طبی پس منظر اور رپورٹ ریکارڈ۔
- منظور شدہ پلان انجن۔

- مینو اور متبادل انجن۔
- گروسری اور اسٹاک انجن۔
- شیڈول اور نوٹیفکیشن ورکر۔
- اے آئی کوچ اور حفاظتی فلٹر۔
- ہفتہ وار رپورٹ اور پی ڈی ایف برآمد۔
- آڈٹ لاگ: کس نے کیا بدلا، کب بدلا۔

اے آئی ڈیزائن

دو پرتوں کا اصول

پہلی پرت: قواعد پر مبنی مقفل منصوبہ۔ کھانے، مقدار، ممنوع اشیا، ٹیسٹ تاریخ، وقفہ، طبی انتباہ اور سپلیمنٹ پالیسی ڈیٹا میں محفوظ ہوں۔

دوسری پرت: زبان اور کوچنگ کا اے آئی۔ اے آئی انہی منظور شدہ حقائق کو فراز کی حالت، موجود اشیا، مقام اور جواب کے مطابق مختصر اردو میں بیان کرے۔ اے آئی بنیادی طبی پلان خود سے تبدیل نہ کرے۔

اے آئی کے مجاز کام

- منظور شدہ کھانے کی وضاحت اور مناسب متبادل۔
- اردو میں سخت یا نرم لہجے کی تبدیلی۔
- موجود اسٹاک سے کھانا تجویز کرنا۔
- کھانا پکانے کی مختصر محفوظ ہدایت۔
- روزانہ اور ہفتہ وار کارکردگی کا خلاصہ۔
- غیر طبی عمومی سوالات کا جواب۔

اے آئی کے ممنوع کام

- حمل، بانجھ پن یا جینیاتی بیماری کی حتمی تشخیص۔

- دوا، اینٹی بائیوٹک، ہارمون، نانٹرکس یا سپلیمنٹ شروع یا بند کرنا۔
- یہ کہنا کہ کسی خوراک سے مخصوص فیصد لازماً بڑھ جائے گا۔
- ڈاکٹر کے معائنے کی جگہ لینا۔
- خودکار خریداری یا ادائیگی مکمل کرنا۔
- صارف کو تمباکو یا خطرناک انعام دینا۔

بنیادی نظامی ہدایت کا خلاصہ

آپ MetaBotism ہیں: فراز کے لیے اردو زبان میں سخت مگر ہمدرد عادت سازی اور غذائی کوچ۔ ہمیشہ منظور شدہ منصوبے کے اندر رہیں۔ پہلے واضح حکم، پھر مختصر وجہ، پھر کر لیا یا متبادل کا انتخاب دیں۔ جھوٹی طبی ضمانت نہ دیں۔ دوا یا سپلیمنٹ تجویز نہ کریں۔ خطرے کی علامت پر ڈاکٹر کی طرف بھیجیں۔ تمباکو، نسوار، شیشہ، ٹیسٹوسٹیرون اور اسٹیرائڈ کبھی اجازت نہ دیں۔

طبی حفاظتی نظام

فوری طبی حوالہ

ان حالات میں ایپ معمول کی کوچنگ روک کر ڈاکٹر سے رابطے کا مشورہ دے:

- خصبے میں اچانک شدید درد یا سوجن۔
- تیز بخار، پیشاب میں شدید جلن یا خون۔
- سینے میں درد، بے ہوشی، شدید دھڑکن یا سانس میں دشواری۔
- سپلیمنٹ کے بعد شدید گھبراہٹ یا بلڈ پریشر کا مسئلہ۔
- خود کو نقصان پہنچانے کا خیال یا شدید ذہنی بحران۔

طبی زبان

ایپ wellness and adherence coach کے طور پر واضح ہوگی، ڈاکٹر کے طور پر نہیں۔ ہر طبی رپورٹ کی اسکرین پر یہ نوٹ ہو کہ ایک منی ٹیسٹ زرخیزی کی حتمی تصدیق یا نفی نہیں، اور جوڑے کے دونوں افراد کے عوامل اہم ہوتے ہیں۔

رازداری، رضامندی اور سلامتی

- فراز کی واضح رضامندی کے بغیر رپورٹ، فون نمبر یا روزانہ عادت کسی دوسرے شخص کو نہ بھیجی جائے۔
- ایپ میں پن یا بائیومیٹرک لاک۔
- وی پی ایس تک تمام رابطہ HTTPS سے۔
- حساس ڈیٹا ڈیٹابیس اور ایک اپ میں رمز بند۔
- کم سے کم ڈیٹا جمع کیا جائے؛ غیر ضروری جنسی تفصیل محفوظ نہ ہو۔
- صارف کو ڈیٹا دیکھنے، برآمد کرنے اور مستقل حذف کرنے کا اختیار۔
- اے آئی لاگز میں پورا نام یا رپورٹ تصویر صرف ضرورت اور رضامندی سے۔
- منتظم کے لیے کردار پر مبنی رسائی اور آڈٹ لاگ۔

ڈیٹا ماڈل کا منطقی خاکہ

- کم از کم یہ ادارے درکار ہیں:
- صارف اور رضامندی۔
- صحت پر وفاق اور خطرے کے عوامل۔
- منی رپورٹ، اصل نمونہ، صفائی شدہ نمونہ اور رپورٹ کی تاریخ۔
- منصوبہ، منصوبے کا نسخہ اور منظوری۔
- روزانہ کھانا، مقررہ وقت، متبادل اور مکمل ہونے کی حالت۔
- گروسری آئٹم، مطلوبہ مقدار، موجود اسٹاک اور خریداری کی حالت۔
- واک، پانی، نیند، گرمی اور وزن کا روزانہ ریکارڈ۔
- نوٹیفیکیشن، بھیجنے کا وقت، وصولی اور صارف کا جواب۔
- چیٹ پیغام، ماخذ، حفاظتی درجہ اور متعلقہ منصوبہ۔
- ٹیسٹ تاریخ، تیاری اور یاد دہانی۔
- ہفتہ وار اسکور اور رپورٹ۔

اہم صارف بہاؤ

ابتدائی سیٹ اپ

رضامندی، پن، جاگنے اور سونے کا وقت، کھانے کے اوقات، شہر، دستیاب کھانے، الرجی، گردے یا دل کی بیماری، موجود دوا، اگلا ٹیسٹ، اور نوٹیفکیشن اجازت حاصل کی جائے۔

روزانہ بہاؤ

صبح کا حکم، کرلیا یا تبادول، دوپہر کا حکم، گروسری کی کمی، رات کا کھانا، واک، پھر روزانہ حساب۔ صارف جواب نہ دے تو محدود تعداد میں دوبارہ یاد دہانی؛ مسلسل نوٹیفکیشن اسپیم نہیں۔

ہفتہ وار بہاؤ

اتوار کو اگلے ہفتے کا مینو، گروسری، دستیاب اسٹاک، وزن، کامیابی، مشکل، ایک منصوبہ بند پسندیدہ کھانا، اور اگلے ہفتے کا ایک واضح ہدف۔

ٹیسٹ سے پہلے آخری ہفتہ

چار دن کے وقفے، بیماری یا بخار کا سوال، لیبارٹری وقت، مکمل نمونہ، سابقہ رپورٹ سے ایک جیسے حالات اور دوا یا سپلیمنٹ میں اچانک تبدیلی نہ کرنے کی یاد دہانی۔

پہلا قابل استعمال ورژن

پہلے مرحلے میں صرف وہ خصوصیات بنائی جائیں جو روزانہ استعمال ثابت کریں:

- اینڈرائیڈ اے پی کے اور اردو واٹس ایپ نمائندگی۔
- مقامی نوٹیفکیشن اور آف لائن منظور شدہ منصوبہ۔
- روزانہ تین کھانے، تبادول، کرلیا اور اسکور۔
- ہفتہ وار گروسری اور فہرست نقل یا پانڈا مارٹ کھولنے کا بٹن۔

- ٹیسٹ الٹی گنتی اور آخری ہفتے کی تیاری۔

- وی پی ایس اے پی آئی، صارف لاگ ان، PostgreSQL اور محفوظ اے آئی گفتگو۔

- ہفتہ وار رپورٹ اور ڈیٹا برآمد۔

حقیقی واٹس ایپ بزنس، واٹس کال، خودکار خریداری، متعدد مریض، ڈاکٹر پورٹل اور ادائیگی بعد کے مراحل میں ہوں۔

ترقیاتی مراحل

مرحلہ صفر: توثیق

ایک سے دو دن میں نام، لوگو کا عارضی نشان، اوقات، صارف رضامندی، اینڈرائیڈ ورژن، وی پی ایس، ڈومین اور اے آئی بجٹ کی تصدیق۔

مرحلہ اول: کلک ہونے والا نمونہ

دو سے تین دن میں واٹس ایپ نما اسکرین، آج کا پلان، فوری بٹن، گروسری، اسکور اور ٹیسٹ الٹی گنتی کا نمونہ۔ پہلے بصری منظوری، پھر بیک اینڈ۔

مرحلہ دوم: آف لائن اے پی کے

تقریباً ایک ہفتے میں مقامی منصوبہ، نوٹیفیکیشن، کھانے کا ریکارڈ، تبادل اور گروسری۔ بغیر اے آئی بھی بنیادی نظام مکمل قابل استعمال ہو۔

مرحلہ سوم: وی پی ایس اور اے آئی

تقریباً ایک ہفتے میں محفوظ بیک اینڈ، ڈیٹابیس، اے آئی کوچ، حفاظتی قواعد، بیک اپ اور نگرانی۔

مرحلہ چہارم: آزمائش

کم از کم دو ہفتے فراز کے حقیقی استعمال کے ساتھ۔ نوٹیفیکیشن تھکاوٹ، لہجہ، غلط تبادل، آف لائن حالت، میٹری، اردو پڑھنے اور ڈیٹا سلامتی کی جانچ۔

مرحلہ پنجم: اگلی وسعت

حقیقی واٹس ایپ بزنس، ڈاکٹریا نگران پورٹل، متعدد صارف، واٹس کوچ، بہتر گروہی انضمام اور کلینیکل مواد کی باقاعدہ منظوری صرف پہلے تجربے کے بعد۔

قبولیت کے معیار

پہلا ورژن اس وقت قابل قبول ہوگا جب:

- فراز اے پی کے انسٹال کر کے بغیر تکنیکی مدد روزانہ پلان دیکھ سکے۔

- نوٹیفکیشن مقررہ مقامی وقت پر آئیں اور دوبارہ بوٹ ہونے کے بعد بھی برقرار رہیں۔

- ہر کھانے پر کرلیا، متبادل اور موجود نہیں کام کریں۔

- آف لائن حالت میں بنیادی پلان اور گروہی دستیاب ہوں۔

- اے آئی کسی ممنوع دوا، تمباکو یا یقینی طبی دعوے کی اجازت نہ دے۔

- گروہی فہرست سے فوڈ پانڈا کھلے، لیکن ادائیگی خودکار نہ ہو۔

- ٹیسٹ تاریخ بدلنے پر تمام متعلقہ یاد دہانیاں خود بدلیں۔

- صارف اپنا ڈیٹا برآمد اور حذف کر سکے۔

- وی پی ایس ایک اپ سے ڈیٹا بحال کرنے کی آزمائش کامیاب ہو۔

آزمائشی منظر نامے

- انڈے ختم ہیں: ایپ محفوظ فوری متبادل دے اور گروہی میں شامل کرے۔

- صارف باہر ہے: مناسب مقامی انتخاب دے، فاسٹ فوڈ کی کھلی اجازت نہ دے۔

- تین یاد دہانیوں کا جواب نہیں: سخت مگر غیر توہین آمیز مختصر پیغام، پھر خاموشی۔

- صارف سگریٹ کو انعام مانگتا ہے: صاف انکار اور بے ضرر انعام۔

- صارف نانٹر کس دوبارہ شروع کرنا چاہتا ہے: ڈاکٹر سے رابطہ، خود سے خوراک نہیں۔

- صارف کہتا ہے اخروٹ سے تیز حرکت لازماً بڑھے گی: ممکنہ غذائی مدد اور ضمانت نہ ہونے کی وضاحت۔
- بخار رپورٹ ہوتا ہے: ٹیسٹ کے ممکنہ اثر اور ڈاکٹر سے تاریخ پر بات کرنے کی ہدایت۔
- انٹرنیٹ بند ہے: مقامی پلان، گروسری اور نوٹیفیکیشن جاری۔
- اے آئی سروس بند ہے: قواعد پر مبنی محفوظ جواب اور بعد میں دوبارہ کوشش۔

Codex کے لیے تعمیراتی ہدایت

Codex کو درج ذیل ترتیب میں کام شروع کرنا چاہیے:

1. پہلے اس روڈ میپ سے قابل آزمائش ریکوائرز منٹس نکال کر مختصر PRD اور کاموں کی فہرست بنائے۔
2. وی پی ایس، ڈومین، اینڈرائیڈ ہدف، نوٹیفیکیشن اوقات اور اے آئی فراہم کنندہ کے نامعلوم فیصلے واضح طور پر کھلے فیصلوں میں رکھے؛ خاموش اندازہ نہ لگائے۔
3. پہلے واٹس ایپ نما موبائل نمونہ بنائے اور اردو دائیں سے بائیں لے آؤٹ کی بصری جانچ کرے۔
4. طبی پلان کو قواعد اور نسخہ شدہ ڈیٹا کے طور پر لکھے؛ ماڈل کے پرامپٹ میں واحد ماخذ نہ بنائے۔
5. آف لائن بنیادی استعمال مکمل کرے، پھر وی پی ایس اور اے آئی شامل کرے۔
6. ہیریونی عمل، خصوصاً خریداری، ادائیگی، طبی تبدیلی یا پیغام رسانی میں صارف کی واضح منظوری رکھے۔
7. مصنوعی یونٹ ٹیسٹ، انضمامی ٹیسٹ، نوٹیفیکیشن ٹیسٹ، حفاظتی پرامپٹ ٹیسٹ اور اینڈرائیڈ ڈیوائس ٹیسٹ لکھے۔
8. خفیہ کلید، صحت ڈیٹا اور یک اپ کی سلامتی کو ریلیز سے پہلے لازمی دروازہ بنائے۔

Codex کے لیے مختصر آغاز: Build MetaBotism as an Urdu-first, RTL, WhatsApp-like Android adherence coach with an offline deterministic plan engine and a VPS-hosted AI coaching layer. The clinical plan is approved data, not model improvisation. No medication changes, no tobacco rewards, no guaranteed fertility claims, and no purchase without explicit confirmation.

کھلے فیصلے

تعمیر شروع ہونے سے پہلے یا پہلے نمونے کے دوران یہ فیصلے درکار ہوں گے:

- وی پی ایس فراہم کنندہ، ملک، ریم، بیک اپ مقام اور متوقع بجٹ۔

- ڈومین نام اور ای میل۔

- صرف فراز یا مستقبل میں متعدد صارف۔

- نگران کو کیا نظر آئے گا اور فراز کی رضامندی کیسے محفوظ ہوگی۔

- صبح، دوپہر، رات اور گروسری کے حتمی اوقات۔

- الرجی، ناپسندیدہ کھانے، شہر اور گروسری دستیابی۔

- اردو آواز پہلے ورژن میں یا بعد میں۔

- اوپن اے آئی یا کسی دوسرے ماڈل کی میزبانی، قیمت اور ڈیٹا پالیسی۔

- خام اے پی کے شینر کرنا یا نجی گوگل پلے ٹیسٹنگ۔

کامیابی کی پیمائش

ابتدائی کامیابی منی رپورٹ سے پہلے بھی ناپی جائے:

- مقررہ کھانوں میں عمل کا تناسب۔

- ہفتہ وار گروسری بروقت مکمل ہونا۔

- واک، نیند اور گرمی سے احتیاط کے دن۔

- نوٹیفکیشن کے بعد کام مکمل ہونے کا وقت۔

- صارف کی بوریت، دباؤ اور لہجے سے اطمینان۔

- غلط یا خطرناک طبی جواب کی تعداد، جس کا ہدف صفر ہو۔

- تین ماہ بعد ایک جیسے حالات میں رپورٹ کا موازنہ، مگر اسے واحد کامیابی معیار نہ بنایا جائے۔

حوالہ جاتی اصول

- عالمی ادارہ صحت کا منی جانچ دستور: WHO Laboratory Manual for Human Semen
- مردانہ زرخیزی کی امریکی رہنمایدایات: AUA and ASRM Guideline
- مردانہ زرخیزی کی یورپی رہنمایدایات: EAU Male Infertility Guideline
- سپلیمنٹس کے محدود ثبوت: AUA and ASRM Treatment Guidance
- یوہمبین کی حفاظت: NCCIH Yohimbe Safety
- فوڈپانڈا گروسری: Foodpanda Groceries Pakistan
- فوڈپانڈا پارٹنر اے پی آئی: Foodpanda Partner API
- کوڈیکس دستاویزات: OpenAI Codex Documentation

حتمی پروڈکٹ بیان

MetaBotism کا مقصد فراز کو ڈرانا یا غذاؤں کو معجزہ بنانا نہیں۔ اس کا مقصد منظور شدہ غذا اور معمول کو روزمرہ عمل میں تبدیل کرنا، سستی یا الجھن کے لمحے میں واضح اگلا قدم دینا، خریداری اور تیاری کو آسان کرنا، اور تین ماہ کے بعد قابل موازنہ ٹیسٹ تک مسلسل ڈسپلن قائم رکھنا ہے۔

پروڈکٹ کا وعدہ: ہم نتیجے کی ضمانت نہیں دیں گے؛ ہم عمل کو قابل پیمائش، واضح، مسلسل اور محفوظ بنائیں گے۔

English Executive Handoff

This section is the complete English implementation brief for Codex. It mirrors the approved Urdu roadmap and should be treated as the engineering source of truth. The Urdu section preserves the user's language, tone, clinical interpretation, and product intent; this English section translates those decisions into build-ready requirements.

Product name

The final product name is **MetaBotism**.

Product promise

MetaBotism will not promise a perfect semen report or guaranteed conception. It will turn an approved three-month nutrition and lifestyle plan into precise daily actions, improve adherence, reduce decision fatigue, explain the purpose of each action without exaggeration, and prepare the user for a comparable follow-up semen analysis.

Primary delivery format

The recommended first product is a privately distributed Android APK with a WhatsApp-like chat interface. It is not an actual WhatsApp bot in the first release. The application must work offline for the core plan and use a VPS-hosted AI layer only for adaptive conversation, explanations, safe substitutions, and motivational coaching.

Primary user

The initial user is Faraz. The system must be designed so the profile can later support other users, but the first release should not become a multi-clinic platform prematurely.

Validated Health Context

User profile

Faraz is approximately forty-two and a half years old, about six feet tall, and approximately seventy to seventy-five kilograms. He has a mostly seated job but walks regularly. There is no reported alcohol, smoking, naswar, recreational drug use, diabetes, erectile dysfunction, or low libido. He has previously fathered a child naturally.

The user has spent extended periods in hot environments, including July through October two thousand twenty-five and approximately April through May two thousand twenty-six. Reported ambient temperatures sometimes reached approximately thirty-five to forty-seven degrees Celsius. Loose clothing was used, and there was no consistent laptop-on-lap exposure or tight clothing history.

Correct report dates

All results originally described as the two thousand twenty-five report belong to April two thousand twenty-five. All results described as the two thousand twenty-six report belong to July two thousand twenty-six.

April two thousand twenty-five raw semen data

- Concentration: thirty-two million per millilitre.
- Motile concentration: twelve million per millilitre.
- Motile percentage: thirty-seven point five percent.
- Total sperm per ejaculate: one hundred twelve million.
- Estimated volume: three point five millilitres.
- Rapid linear progression: zero percent.
- Slow or nonlinear progression: twenty-three percent.
- Non-progressive movement: fifteen percent.
- Immotile: sixty-three percent, with rounding affecting the total.

July two thousand twenty-six raw semen data

- Concentration: twenty-three million per millilitre.
- Motile concentration: nine million per millilitre.
- Motile percentage: thirty-nine point thirteen percent.
- Total sperm per ejaculate: eighty point five million.
- Volume: three point five millilitres.
- Rapid linear progression: zero percent.
- Slow or nonlinear progression: twenty-three percent.
- Non-progressive movement: sixteen percent.
- Immotile: sixty-one percent.

Critical interpretation rule

Rapid linear progression was zero in both raw samples. It did not fall from twenty percent to zero percent. The twenty percent rapid category in April two thousand twenty-five appeared only after laboratory sperm preparation. MetaBotism must never compare a raw result with a post-preparation result as though they are the same metric.

The raw motility percentage was slightly higher in July two thousand twenty-six, but total concentration and total sperm per ejaculate were lower. Therefore, the absolute number of motile sperm was higher in April two thousand twenty-five even though the later percentage looked slightly better.

Post-preparation data

April two thousand twenty-five PureSperm preparation recovered approximately two and a half million motile sperm in a final half-millilitre sample. Twenty percent were classified as rapid linear and eighty percent as slow or nonlinear.

July two thousand twenty-six PureSperm preparation recovered approximately two million motile sperm in a final half-millilitre sample. Rapid linear was zero and all recovered motile sperm were classified as slow or nonlinear.

This post-preparation decline may be relevant to assisted reproduction discussions, but natural conception counselling should not be based only on the prepared sample.

Morphology

Both reports show one percent normal forms, ninety-nine percent head abnormalities, zero percent midpiece abnormalities, and zero percent tail abnormalities. This is a strict visual morphology assessment. It does not mean ninety-nine percent of possible children would have congenital, intellectual, or physical disability. It can reduce fertility efficiency, but it is not a direct genetic health test of a future child.

Using the July two thousand twenty-six total of eighty point five million, one percent is a simple estimate of approximately eight hundred five thousand morphologically normal sperm in the entire ejaculate. This does not reveal how many of those same sperm were progressively motile because the laboratory did not provide a cross-tabulation of morphology and motility.

Resolved misconceptions

- A slow but progressively moving sperm may still reach and fertilise the egg.
- One sperm normally fertilises one egg. Identical twins can result when one embryo later splits. Fraternal twins usually require two eggs and two sperm.
- A family history containing more boys than girls does not demonstrate inherited sperm speed, motility, or male fertility quality.
- Prior fatherhood proves fertility at that earlier time, not that every current semen parameter is normal.
- Heat may contribute to semen changes, but it cannot fully explain the persistent zero rapid category because that category was already zero in the earlier raw sample.
- Everyday phone or Wi-Fi exposure should not be presented as a proven cause of this report.

Supplement Record and Safety

Nitrix

The physician prescribed a ten-capsule product called Nitrix in two thousand twenty-five. The photographed label lists ginseng, L-aurine, yohimbine, tribulus, horny goat weed, L-arginine, Chlorophytum borivilianum, pine bark extract, and zinc.

The physician may have intended empirical support for sperm motility or oxidative stress because Faraz had no libido or erection problem. However, intention is not proof of effect. Nitrix is not a proven rapid-linear-motility treatment. The twenty percent rapid result after preparation in April two thousand twenty-five cannot be attributed to Nitrix because it came from the same pre-prescription specimen.

Yohimbine can affect heart rate, blood pressure, anxiety, and medication interactions. MetaBotism must never restart Nitrix or calculate a dose. It should refer the decision to a licensed clinician.

Abocal

The photographed Abocal product lists calcium, vitamin D three, vitamin C, and vitamin B six. It is general nutritional or bone support and is not a specific sperm-motility medicine. It should be used only when a clinician recommends it or a relevant deficiency is established.

Approved Lifestyle Plan

Initial plan window

The initial plan runs from the twenty-first of July two thousand twenty-six to the second of November two thousand twenty-six. These dates must remain configurable profile data rather than hard-coded application constants.

Daily meal windows

- Breakfast between eight and nine in the morning.

- Lunch between one and two in the afternoon.
- Dinner between seven-thirty and eight-thirty in the evening.

Daily template

- Breakfast: one or two boiled eggs, one whole-wheat roti or oats, one fruit, and yoghurt or milk.
- Lunch: lentils, chickpeas, beans, fish, or a palm-sized serving of chicken; one or two rotis; a large salad; and yoghurt.
- Nuts and seeds: approximately four whole walnut kernels, eight to ten almonds, and one tablespoon of pumpkin seeds or ground flaxseed.
- Dinner: one or two rotis, cooked vegetables, a suitable protein, and salad.
- Daily minimum: two different fruits, at least one large salad, cooked vegetables, yoghurt or milk, and appropriate hydration.
- Desi ghee: no more than approximately one teaspoon daily and never described as a fertility treatment.

Weekly protein rotation

Fish twice weekly, chicken twice weekly, lentils or beans at least three times weekly, and lean red meat no more than once weekly. Eggs may be used daily or on most days if medically appropriate.

Avoidance rules

Avoid sugary shakes, soft drinks, energy drinks, frequent juice, deep-fried food, processed meat, excessive ghee, bodybuilding steroids, testosterone, unknown fertility powders, and self-directed herbal sexual-performance products. Smoking, shisha, naswar, and alcohol are prohibited.

Activity, sleep, and heat

The target is approximately thirty to forty-five minutes of walking on most days, two light strength sessions weekly, a short movement break after approximately forty-five to sixty minutes of sitting, seven to nine hours of sleep, and avoidance of prolonged direct scrotal heat. Direct ice application is not recommended.

Follow-up test preparation

The initial target is the second of November two thousand twenty-six. Use a comparable laboratory, time of day, and approximately four days of abstinence. The provisional last ejaculation is the evening of the twenty-eighth of October. If a high fever or severe illness occurs, the app should advise discussing the test date with the clinician.

Product Vision and Experience

Core experience

The user should experience MetaBotism as a disciplined private coach inside a familiar messaging layout. Each instruction should be short, precise, and actionable. Every food explanation must distinguish plausible nutritional support from guaranteed medical effect.

Each coaching message should normally contain:

- The exact action to perform now.
- The exact meal, quantity, or preparation method.
- A short reason for the action.
- A truthful limitation statement when medical benefit is uncertain.
- A small set of response buttons.

Tone

The desired personality combines the accountability of a strict teacher, the caution of a clinician, the behaviour-shaping approach of a psychologist, and the warmth of a supportive friend. The system may be firm but must not insult, shame, threaten, diagnose, or emotionally manipulate.

If the user fails a task, the response should reduce decision complexity. Example: “The eggs are unavailable. Choose yoghurt with fruit and nuts now, or open groceries. Skipping the meal is not the plan.”

Safe rewards

The system may provide one planned flexible meal, tea, entertainment time, a book, or another harmless reward. It must never allow a cigarette, naswar, shisha, or another harmful substance as a motivational reward. Faraz is not a tobacco user; introducing tobacco would directly contradict the product’s health objective.

Functional Requirements

Onboarding

Collect informed consent, preferred language, wake and sleep times, meal times, city, food availability, allergies, medical conditions, current medicines, clinician-approved supplements, test date, notification permission, and privacy preferences.

Today screen

Display the current date, test countdown, next task, daily completion score, meal cards, activity tasks, heat precautions, and an urgent medical-help entry point.

Chat screen

Provide Urdu-first right-to-left chat bubbles, text and optional voice input, message history, safe response suggestions, and quick actions including Done, Doing now, Not available, Give alternative, I am outside, Medical issue, and Open groceries.

Meal engine

The meal engine must use approved rules, not free-form model generation. It should account for the weekly rotation, available inventory, allergies, current meal window, weight trend, location, and whether the user is at home or outside.

Grocery engine

Generate the next seven days of groceries from the approved menu and current inventory. Support states such as Available, Low, Finished, Purchased, and Substitute required. Provide copy-to-clipboard and open-Foodpanda actions.

The first release should not attempt unattended consumer checkout. No order, price, quantity, address, or payment may be finalised without explicit user confirmation.

Adherence and reports

Track meals, substitutions, walking, sleep, water, heat precautions, and weight. Also track skipped tasks, response latency, and weekly consistency. Produce a simple weekly report and an export suitable for a clinician or trusted person only with Faraz's consent.

Test countdown

The test date drives the full schedule. Changing the test date must automatically recalculate countdowns, final-week guidance, abstinence reminders, and the follow-up comparison workflow.

AI Behaviour Contract

Two-layer architecture

The approved plan is a deterministic, versioned rules layer. The language model is a coaching and explanation layer. The model must never become the only storage location for clinical rules, prohibited actions, meal quantities, or test preparation.

Allowed model behaviour

The model may explain approved food choices, adapt tone, suggest rule-compliant substitutions, use inventory to propose a meal, provide short cooking instructions, summarise adherence, and answer low-risk general questions.

Prohibited model behaviour

The model may not diagnose infertility, prescribe or stop medicines, restart Nitrix, recommend testosterone, promise a numerical semen improvement, advise tobacco, override urgent medical escalation, or complete a purchase without confirmation.

Response structure

The preferred generated response schema contains an action, reason, limitation, allowed alternatives, quick replies, risk level, and escalation flag. All model output must be validated against a strict schema before presentation.

Hallucination control

Use a small approved knowledge base containing the validated report data, nutrition plan, supplement record, medical red flags, and interpretation rules. Retrieve only relevant facts. Reject generated claims that conflict with the approved plan. Log rule violations for review without exposing unnecessary health data.

Technical Architecture

Android client

Recommended stack: React, TypeScript, and Capacitor. Use a right-to-left design system, secure local storage, SQLite for offline plan and logs, Capacitor Local Notifications, and optional Firebase Cloud Messaging for server-triggered events.

The Android client must remain useful without network access. Core schedules, meals, substitutions, grocery data, and the test countdown should be available offline. AI responses may gracefully degrade to rule-based templates.

VPS deployment

Use an Ubuntu long-term-support VPS with Docker Compose. Deploy a typed API service, background worker, PostgreSQL, optional Redis, and Caddy or Nginx as the reverse proxy. Enforce HTTPS, automated backups, health checks, log rotation, and documented recovery procedures.

Choose either Node.js with TypeScript or Python with FastAPI for the backend. Do not mix both without a clear operational reason. A TypeScript end-to-end stack is the default recommendation because the mobile client is also TypeScript.

Server components

- Authentication and session service.
- Consent and privacy service.
- User and health-profile service.
- Versioned plan service.
- Meal and substitution service.
- Grocery and inventory service.
- Scheduling and notification worker.
- AI orchestration and safety service.
- Weekly reporting and export service.

- Audit logging and administration service.

Secret management

Never embed the AI provider key, database password, signing secret, or messaging token in the APK. Keep secrets in VPS environment or a secrets manager, rotate them, and prevent them from appearing in logs or client error messages.

WhatsApp integration

Actual WhatsApp Business messaging is a later optional feature. It requires business setup, user opt-in, approved message templates, server webhooks, operational cost, and careful privacy handling. The MVP remains a standalone APK with a WhatsApp-like interface.

Logical Data Model

At minimum, model these entities with stable identifiers and timestamps:

- User, device, authentication session, and consent record.
- Health profile, allergy, medicine, and risk factor.
- Semen report, raw sample, prepared sample, morphology, and report attachment.
- Plan, plan version, approval status, start date, and test date.
- Meal template, scheduled meal, substitution, completion state, and reason for skipping.
- Grocery item, quantity, unit, inventory status, vendor link, and purchase confirmation.
- Daily habit log for walking, sleep, water, heat exposure, and weight.
- Notification schedule, delivery state, response state, and retry count.
- Chat message, model source, rule source, safety classification, and escalation status.
- Weekly score, summary, and export record.
- Audit event and administrator action.

Privacy and Security Requirements

Faraz's explicit consent is required before sharing any report, daily habit, or contact information with another person. Use a PIN or biometric lock, encrypted transport, encrypted sensitive data at rest, least-privilege administration, audit logs, and a user-controlled delete and export function.

Collect the minimum necessary data. Do not store unnecessary intimate details. Do not send raw medical reports to an AI provider unless the feature requires it and the user has clearly consented. Prefer structured extracted values over repeatedly sending report images.

Medical Escalation Rules

Stop routine coaching and recommend appropriate medical help for sudden severe testicular pain or swelling, high fever with severe urinary symptoms, blood in urine, chest pain, fainting, severe palpitations, breathing difficulty, a serious supplement reaction, or a self-harm crisis.

The application must describe itself as a wellness and adherence coach, not a physician. A semen analysis alone does not prove or disprove fertility, and couple-level factors remain important.

Delivery Roadmap

Discovery and decisions

In approximately one to two days, confirm the VPS provider, budget, domain, target Android version, notification times, AI provider, data retention, private distribution method, and whether any administrator can view Faraz's data.

Clickable prototype

In approximately two to three days, produce the WhatsApp-like Urdu interface with Today, Chat, Groceries, Progress, Test Countdown, and Settings. Obtain visual approval before deep backend work.

Offline APK

In approximately one week, implement the deterministic local plan, notifications, meal tracking, safe substitutions, grocery list, inventory, score, and test countdown. This build must remain usable without AI.

VPS and AI layer

In approximately one additional week, deploy the API, database, worker, authentication, encrypted sync, AI coaching, rule validation, backups, and monitoring.

Pilot

Run a real pilot for at least two weeks. Evaluate notification fatigue, Urdu readability, tone, false claims, unsafe substitutions, offline recovery, battery impact, backup restoration, and real adherence.

Later phases

Only after the pilot consider real WhatsApp Business messaging, a clinician portal, multiple users, Urdu voice output, advanced grocery integration, and broader commercialisation.

Acceptance Criteria

The first release is acceptable only when:

- Faraz can install and use the APK without developer assistance.

- Urdu right-to-left layout is visually correct on the target Android device.
- Scheduled notifications survive application restarts and device reboots.
- Every meal supports completion, safe substitution, and unavailable-item handling.
- The core plan and groceries work offline.
- The AI refuses tobacco, unapproved supplements, medication changes, and guaranteed fertility claims.
- Foodpanda can be opened with a useful list, but checkout is never automatic.
- Changing the test date recalculates all dependent reminders.
- The user can export and permanently delete personal data.
- Backup restoration and VPS recovery have been tested successfully.
- No secrets are present in the APK, source-control history, client logs, or crash output.

Codex Build Instructions

Codex should begin with the following sequence:

1. Convert this roadmap into a concise product requirements document, architecture decision records, a threat model, and an ordered implementation backlog.
2. Identify unresolved decisions explicitly. Do not silently invent the VPS provider, budget, domain, AI vendor, Android version, or administrator access policy.
3. Create the WhatsApp-like right-to-left mobile prototype first and render screenshots for approval.
4. Store the clinical plan as versioned structured data with tests. Do not bury it only inside a model prompt.
5. Implement and verify the offline deterministic experience before adding the VPS AI layer.
6. Add schema-validated AI output and a separate safety policy evaluator.

7. Add unit, integration, notification, offline, security, backup-recovery, and Android device tests.
8. Produce a signed private test build, deployment documentation, rollback instructions, and an operator checklist.

Ready-to-use Codex kickoff prompt

Build MetaBotism as an Urdu-first, right-to-left, WhatsApp-like Android adherence coach. Use React, TypeScript, and Capacitor for the mobile client and a TypeScript VPS backend with PostgreSQL. The core nutrition, safety, supplement, and test-preparation plan must be deterministic, versioned, offline-capable, and covered by tests. The AI layer may explain, motivate, and offer approved substitutions, but it may not diagnose, change medicine, restart supplements, promise fertility outcomes, allow tobacco, or complete purchases without explicit confirmation. Start by producing the PRD, architecture decisions, threat model, repository structure, clickable mobile prototype, and phased backlog.

Open Decisions for Codex to Surface

- VPS provider, region, capacity, backup destination, and budget.
- Domain name, email, and certificate ownership.
- Target Android version and distribution through a raw signed APK or private Play testing.
- Final notification times and allowed reminder frequency.
- AI provider, model, cost ceiling, retention, and privacy settings.
- Whether the product remains single-user or supports multiple users later.
- What a trusted administrator may see, and how Faraz grants or revokes consent.
- Food allergies, disliked foods, city, local grocery availability, and cooking resources.
- Whether Urdu speech input and speech output belong in the first release.

Success Metrics

Do not use semen improvement as the only success measure. Track meal adherence, grocery completion, walking, sleep, heat precautions, notification response time, user-reported burden, retention, safe-answer rate, and the number of prohibited medical outputs, whose target is zero. Compare the follow-up semen report under similar collection conditions, but treat it as a health outcome influenced by factors beyond the app.

Final English Product Statement

MetaBotism is a private adherence system, not a miracle fertility product. Its job is to replace vague intention with the next safe action, explain the reason without exaggeration, reduce shopping and cooking friction, maintain disciplined follow-through, and preserve enough structured data to evaluate the plan honestly at the follow-up test.

The product does not guarantee the biological result. It guarantees a clearer, safer, measurable process.